第 一 章

你的胃，最先撑不住

> 高中三年，身体最先出问题的地方，大概率不是脑子，是胃。

六点四十，从食堂出来，手里一个饼。走到宿舍楼下正好啃完，塑料袋扔进门口的桶里。

上午第二节课，胃里开始发胀，像塞了团湿棉花。中午不太想吃，扒了两口。晚自习前又饿，从柜子里翻出两个从家里带来的小面包。

十一点躺下，肚子里咕噜咕噜地响。药盒在枕头边上，一直没打开。

寄宿学校的一个普通早上

这不是谁的特例。你翻开任何一个高三学生的抽屉，大概率能找到一盒消食片；问一句「胃怎么样」，得到的回答多半是「还行吧」，然后补一句「就是有时候胀」。

「还行吧」这三个字，是这个群体最标准的一种回答。它不代表没事，它代表**还没到忍不住的程度**。

1.1 胃为什么最先垮

胃是个特别被动的器官。它不挑你给它什么，只按你给的节奏干活。你给它什么温度、什么速度、什么时间，它就照着反应——而且从不抗议，只是记账。

第一笔账：吃得太快

咀嚼是消化的第一步。牙齿没干的活，会原封不动地推给胃。一口饭嚼五下就咽，胃就得用几倍的力气去磨。更麻烦的是空气——边走边吃、边说话边吃，吞进去的气量会翻好几倍。你觉得「胀」，很大一部分不是食物，是气。

第二笔账：时间乱

胃酸不是随时待命的。它有自己的分泌节律，大致跟着你平时的饭点走。今天七点吃、明天十二点吃，胃酸就会在错的时间出现：该有食物的时候空转，烧的是自己的黏膜；食物真来了，酸又不够，消化不动，还是胀。

第三笔账：吃完就躺

胃和食管之间有个阀门，叫贲门。趴桌、平躺、弯腰，腹压一高，胃里的东西就往上顶。烧心、反酸、喉咙里泛酸味，多半是这么来的。二十分钟的午睡能救回下午的课，但趴着睡的那二十分钟，胃在倒着干活。

还有两笔，不那么直接

睡不够。胃黏膜的修复主要在夜里进行。睡不够，修复时间就不够，黏膜的防御力跟着下降。这也是为什么熬夜之后的第二天，胃特别容易不舒服——不是巧合。

压力大。人紧张的时候，身体会切到应急模式：血液优先供给肌肉和大脑，消化系统被暂时关掉。偶尔一次没事。但如果这种状态持续几个月——月考、排名、家长会、倒计时牌——胃肠就会换一种方式提醒你：一考试就肚子疼，一

进考场就想上厕所，吃什么都胀。

这不是「心理作用」。这是真实的生理反应，有明确的机制，也有明确的应对办法。

1.2 现在这个状况，算不算事

下面这八种，是寄宿学校里最常见的。找到最像你的那条，看右边两栏。

吃完饭胀、老打嗝

大概率是

吃太快、吞气多，或者一顿吃太饱

现在能做

这顿慢点吃，饭后走十分钟，别马上坐下

什么时候该去医务室

连续两周以上没好转，或者体重在掉

早上起来恶心、不想吃

大概率是

前一晚吃太晚或太多，胃还没排空

现在能做

睡前 3 小时别再进食；早上先喝两口温水

什么时候该去医务室

反复呕吐，或者吐到喝不进水

反酸、胸口烧

大概率是

吃完就躺、吃太饱，贲门关不严

现在能做

饭后两小时别躺；睡觉把枕头垫高一点

什么时候该去医务室

吞咽困难，或者体重不明原因下降

肚子咕噜、放屁多

大概率是

吞气、乳糖不耐、豆类或碳酸饮料

现在能做

少喝碳酸；吃东西时把嘴闭上嚼

什么时候该去医务室

伴随腹泻、发烧，或者便里有黏液

三四天没排便

大概率是

水喝太少、纤维太少、坐得太久

现在能做

今天多喝两杯水，课间绕操场走一圈

什么时候该去医务室

超过一周，或者便中带血

一紧张就肚子疼、想上厕所

大概率是

情绪相关的肠道反应，这个年龄段很常见

现在能做

把呼吸放慢，呼气比吸气长；别空腹喝冷饮

什么时候该去医务室

疼到没法上课，或者已经影响到考试

疼得冒冷汗、位置固定、按下去更疼

大概率是

不是普通的「胃不舒服」，需要人看一眼

现在能做

别再忍，也别自己加药

什么时候该去医务室

现在就去，别等下课

一天拉三次以上、水样

大概率是

急性腹泻，多数是吃坏了或受凉

现在能做

补口服补液盐，别只灌白开水

什么时候该去医务室

口干、尿少、站起来发晕——这是脱水

出现下面任何一条，不用再观察

- 大便发黑、像柏油，或者呕出血
- 肚子持续剧痛超过 6 小时，而且越来越重
- 发烧超过 38.5℃
- 明显脱水：口干、尿少、站起来发晕
- 没刻意减肥，体重却在往下掉

这几条不代表一定很严重，但它们都过了「自己扛一扛」的界限。去医务室，或者让家里来接。

去医务室之前，先在心里过三样：什么时候开始的、吃了什么、疼了多久。这三样比「我肚子疼」有用得多——第七章还会用到。

1.3 这几个习惯，代价是什么

不谈「应该不应该」，只算账。左边是你现在做的，中间是这周你就会感觉到的，右边是三年之后它会拿走的东西。

习惯	短期内	长期
边走边吃，五分钟解决一顿	上午胀气、打嗝	胃动力紊乱，吃一点就饱
吃完趴桌上睡二十分钟	醒来嘴里发酸	贲门松弛，反流变成常态
用零食顶掉一顿正餐	半小时后更困	胃酸空转，黏膜慢性受损
有便意憋着，等下课	肚子胀、放屁多	直肠反应变迟钝，便秘固化
胃疼就吃片止痛药顶过去	疼是压下去了	布洛芬这类药本身伤胃，还会盖住真实病情

最后一条值得多说一句。止痛药不是不能吃，但反复胃疼、反复靠止痛药顶，是最糟的一种处理方式——它既没解决问题，又让问题变得更难看清，还顺手在胃黏膜上添了一笔。

1.4 十分钟，怎么吃对一顿

不要求你每顿都吃好。要求的是：一天里有一顿，是坐下来、慢慢吃完的。有这一顿，剩下的就好办很多。

1 先找一个「有蛋白质」的

鸡蛋、牛奶、豆浆、瘦肉、豆腐。食堂打菜时优先挑带肉的，或者加个蛋。蛋白质是最能拖住饿的那样东西——一顿里只有碳水，两节课就见底了。

2 **再加一个「能嚼的」**

一份青菜、一个玉米、半个红薯。纤维让胃有活干，也让血糖升得慢一点，不至于第三节课就犯困。

3 **水放在饭前，不要饭中猛灌**

饭前一杯水不占地方；吃饭时灌一大杯，胃被撑开，胀气来得更快。

如果只有十分钟，只能在路上吃

食堂打包：米饭 + 一份带肉的菜 + 一份青菜。带回宿舍吃没问题，但坐下来吃，别站着扒完。

只能买个饼：配一杯奶，或者加个鸡蛋。奶要是食堂没有，就自己带一箱进来。饼管饱，但撑不到第四节课——缺的是蛋白质。

早饭是最不该省的一顿。一上午六节课，空着肚子撑到中午，胃酸空转的时间比你想的长。

真正决定这三周吃得好不好的，不是你每天在窗口前挑什么，是返校那天箱子里装了什么。**这件事放在第二章。**

胃很能忍。它不舒服的时候不吭声，等它吭声，通常已经忍了很久。